Diskussion 1762

Datum: 1928-03-21
Kammare: Andra kammaren
Antal yttranden: 4
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus, byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).
Projekt: https://github.com/DigitalHistory-Lund/ToK-Preparer
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18211787
Version: 2026.10.14

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Jakob Pettersson (–, man)

Herr talman! Utskottet har funnit sig icke kunna tillstyrka propositionens förslag om anslag till s. k. egna läkarebilar. Detta förslag är föranlett av en skrivelse av år 1920, vari riksdagen begärde utredning, huruvida och på vilket sätt det skulle kunna åstadkommas bättre transporter av sjuka till och från sjukhus på landsbygden. I det utskottsutlåtande, som låg till grund för riksdagens beslut, uttalades, att man avsåg en utredning av alla de spörsmål, som innefattades i den stora frågan, sålunda icke endast transport av sjuka. Röda korsets överstyrelse, som haft Kungl. Maj:ts uppdrag att utreda ärendet, har i anledning därav avlämnat en ganska vidlyftig plan till fullständigt ordnande av sjuktransportväsendet på landsbygden. Överstyrelsen föreslår däri förbättring av Järnvägarnas sjuktransportmedel, anslag till sjuktransportaeroplan, anslag till skidbårar och slädfordon för transport av sjuka och slutligen anslag till flera olika slag av sjukbilar. Av alla dessa förslag har jag förordat anslag endast till skidbårar och s. k. egna läkarbilar. Utskottet har däremot tillstyrkt endast det förstnämnda av dessa bägge anslag.

Propositionens förslag beträffande läkarbilarna går ut på att det skulle lämnas bidrag, ett belopp av minst 1,000 och högst 2,500 kronor till anskaffande, drift och underhåll av läkarbilar, under förutsättning, att sådana bilar voro inrättade på det sättet, att de kunde rymma en sjuk person i liggande ställ-

ning, och att de voro försedda också med bår. Anslag skulle utgå dels till tjänsteläkare dels till landsting, landskommuner, kommunalförbund och sjukvårdsföreningar. Villkor för åtnjutande av anslag skulle bl. a. vara, att vederbörande förbunde sig att under två år hålla automobilen tillgänglig för transport av läkare på deras tjänsteresor, för transport av sjuka till sjukhus och för transport av distriktsbarnmorskor och distriktssköterskor, då dessa skulle på sjukbesök, som vore särskilt trängande. Utom detta anslag skulle utgå ersättning efter taxa motsvarande självkostnaden för transport av läkare, sjuka, **barnmorska³** eller **sjuksköterska³**, dock icke till läkare i den händelse han själv var ägare av bilen och icke heller om läkaren i samma bil också skjutsade **sköterska³** eller **barnmorska³**.

Nu har utskottet som sagt avstyrkt detta anslag. Utskottet anser nämligen att den föreslagna

anordningen är behäftad med bristfälligheter, särskilt i det avseendet att ordningen för utnyttjandet icke skulle bliva tillfredsställande. Jag antager att utskottet menar, att man icke på förhand har klarlagt, huru det skulle ställa sig med begagnande av bilarna, då flera funnes, som skulle ha dem, o. s. v. Och av diskussionen i första kammaren framgår, att man anser det vara en brist, att det icke föreligger förslag om chaufförer till bilarna. Jag erkänner gärna, att förslaget kunde vara mera i detalj utformat, och att det kanske vore bättre, om anslaget kompletterats med ett anslag till chaufförer. Men jag håller i alla fall före, att den planerade anordningen, sådan den framgår av propositionen, skulle vara ägnad att göra nytta. Jag vill erinra om, att förslaget endast är en ytterligare utvidgning av de principer, som på detta område redan tillämpas i vissa ödemarksområden. Och vidare vill jag framhålla, att anordningen ju är att betrakta såsom ett försök. I den händelse det skulle visa sig, att anordningen verkligen är förenad med olägenheter, finge man se till att avhjälpa dem. Jag håller i alla fall bestämt före, att det vore en stor fördel att ha en bil med anordning för transport av liggande sjuk på åtskilliga håll, där man annars icke skulle vara försedd med sådant transportmedel. Och det vore bättre att ha en bil, som vore försedd med ifrågavarande särskilda anordningar, än att ha en bil utan sådana. För övrigt vill jag framhålla, att de myndigheter som haft att yttra sig över Röda korsets förslag, i allmänhet ha tillstyrkt just detta förslag. De andra förslagen ha varit mera utsatta för kritik, men detta har man funnit lämpligt och praktiskt.

Jag vågar naturligtvis icke påstå, att detta är någon stor fråga. Men jag vill å andra sidan också säga. att den därför ingalunda är oviktig. De, som någon tid vistats på landet, känna nog till, vilka lidanden som tillskyndas sjuka därigenom, att lämpliga transportmedel icke finnas till hands, och litet var torde också ha reda på, att när det gäller transport av sjuka, det ofta är mycket viktigt, att transporten kan ske omedelbart, och att det finnes fall, då en hastig transport kan tjäna till att rädda människoliv. Jag undrar, om icke just dessa omständigheter borde vara ägnade att få kammaren att bevilja detta anslag. Till sist vill jag tala om, att första kammaren med mycket stor majoritet bifallit reservationen. Jag vågar, herr talman, hysa den förhoppningen, att andra kammaren skall komma till samma resultat.

2. Robert Jansson (Socialdemokraterna, man)

Jag vill gärna erkänna, att det var ett behjärtansvärt moment i Kungl. Maj:ts förslag, men det är också ett behjärtansvärt moment i den nu föreliggande reservationen. Nu är det ju som departementschefen redan har påpekat så, att anslag utgår till vissa läkarbilar i ödemarksdistrikten. Men vi ha flera län inom vårt avlånga och vidsträckta land, som ha mycket långa avstånd till läkare, och jag menar, att det kan vara fullt berättigat, att man sträcker ut denna hjälp, så att även dessa må kunna få ett visst bidrag till anskaffande av ett fortskaffningsmedel av nu ifrågavarande slag. Jag

kan icke finna annat, än att det så principiellt nära hör samman med det anslag, som riksdagen beviljat till rikets ödemarksdistrikt, att man mycket väl kan gå in för vad här föreslås. Det är ingen ny princip, man går in för, utan det är bara det, att man utsträcker tillämplighetsområdet av en gammal princip att gälla över hela landet. Men den summa, som

här föreslås, är så knappt tilltagen, att det är självklart, att man måste begränsa sig till de län, där avstånden äro som längst, och där läkarna ha de största och vidsträcktaste distrikten. Jag har för övrigt icke något vidare att tillägga. Jag skall be att få ge min fulla anslutning till den synpunkt, som har framförts från statsrådsbänken. och be att få yrka bifall till den reservation, som är bifogad den nu föredragna punkten.

3. Olof Olsson (Bondeförbundet, man)

Herr talman! Jag talade nyss i en annan fråga om konsekvenser. Man har sagt, att det icke är så farligt med konsekvenser. Det hela inskränkte sig ju bara till den fråga, som för tillfället diskuterades. Men nu har ju både herr statsrådet och den siste ärade talaren varit inne på den tankegången, att man bör bevilja detta anslag, just för att det endast är en konsekvent tillämpning av en linje, man förut gått in för. De anse. att man som en konsekvens därav skall taga detta förslag, och småningom sträcka ut tillämpningen från ödemarksområdena till hela landet. Man får taga det etappvis. mena herrarna. Konsekvenser kommer man sålunda inte ifrån.

Jag hoppas i alla fall, att en annan konsekvens av sjukvården i ödemarksområdena skall man slippa ifrån. Ehuru man beträffande vården av de sjuka 1 ödemarksområdena gått in för, att aeroplan skola hämta dem till sjukhus, hoppas jag i alla fall, att herr statsrådet icke vill gå in för att detta skall ske i hela landet. Då kanske herrarnas konsekvenser bliva väl stora.

Då man ser detta förslag fristående och icke hänger upp sig på konsekvenser, kan jag icke finna annat, än att detta i stort sett endast blir ett anslag åt tjänsteläkarna. Ty en tjänsteläkare, som reser ut, skall ju ha precis lika stor reseersättning ändå. Vad han enligt detta förslag får för bilen, blir ju för honom nästan en ren vinst. Den där förändringen, som behöver göras med bilen, för att den skall kunna taga in en sjukbår med en sängliggande sjuk, är sannerligen icke så stor eller kostar så mycket pengar. Jag tycker vi så nyligen haft löneregleringför provinsialläkarna, och därvid togo synnerlig hänsyn till storleken och vidlyftigheten av deras distrikt, att man icke behöver ge dem ytterligare förmåner. De löner de fingo voro, tycker jag, för resten icke så njugga. De ha ju dessutom en viss inkomst även på — jag vet icke om jag vågar kalla det så — sportler. De ha ju särskild ersättning för receptskrivning, sjukbesök m. m. Jag tror alltså icke, det är så klent ställt för tjänsteläkaren, att man behöver tillgripa denna metod för att förbättra hans lön. Det var det första Jag ville säga. För det andra skulle bilen ha en mycket allmännyttig uppgift. Den skulle skjutsa läkare och sjuka, barnmorskor och **sjuksköterskor**[3]. Ja, i vad ordning de egentligen skulle äga rätt disponera bilen, det är ju svårt att säga. De flesta i utskottet tyckte i alla fall, att den där sammanblandningen skulle nog bliva synnerligen besvärlig, och vi ansågo, att saken väl ändå finge ordnas så, att bilen skulle vara läkarens bil. Då man nyligen reglerat lönerna för läkarna, ha vi icke ansett det vara lämpligt att nu gå in för understöd i form av »bilpengar». De allra flesta läkare använda ju numera bilar vid sjukresor. Många läkare ha skaffat sig egen bil och äro sina egna chaufförer. och det går alldeles förträffligt. Jag har inte hört dem ifrågasätta, att det skulle vara nödvändigt att anskaffa kungl. statsbilar. Nu har naturligtvis statsrådet alldeles rätt i att riksdagen år 1920 skrev och begärde en utredning. Det var under den stora

ekonomiska galenskapens tid, de där åren 1917, 1918. 1919,

1920 och en liten bit in på år 1921. Sedan nyktrade man till en smula, men under den där tiden hade folk olyckligtvis för mycket pengar, och då funderade man ut alla möjliga sätt att bli av med pengarna. Så gjorde både de enskilda och staten. Jag tror ändå, att folk i allmänhet nyktrat till litet sedan dess. Statsrådet och chefen för socialdepartementet har också starkt beskurit Röda korsets anslagsyrkanden. Emellertid förstår jag icke, varför statsrådet, när det gällde att välja mellan dessa yrkanden, förordat just förslaget om att staten skulle lämna bidrag till dessa gemensamma bilar för läkare, **sjuksköterskor**[3] och barnmorskor. Jag hade bättre förstått, om han föreslagit, att staten skulle bidraga till anskaffande av ambulansbilar.

Så länge vi ha det så ordnat, att staten skall sörja för inrättande av sinnessjukanstalter och landstingen för övriga sjukvårdsinrättningar, bör anskaffandet av bilar för sjuktransport vara en landstingens och icke en statens angelägenhet. De pengar, staten kan avvara för sjukvårdsändamål, böra i första hand användas till förbättrande av sinnessjukvården, som för närvarande är mycket sämre ordnad än den allmänna sjukvården. Så länge staten icke klarat sinnessjukvården, bör staten låta landstingen sköta den övriga sjukvården. Jag tror, det är en mycket förnuftig uppdelning, och ju mera var och en sköter sitt, desto bättre går det. Först när staten ordnat sinnessjukvården på ett tillfredsställande sätt, kan det enligt min uppfattning bli tal om att staten skall lämna bidrag till den allmänna sjukvården, naturligtvis dock endast under förutsättning, att staten då befinner sig i en sådan ekonomisk situation, att staten kan göra det. Vad som är av vikt för staten, det är att sköta sinnessjukvården litet bättre än hittills. Landstingen kunna nog skaffa bilar för sjuktransporter, och läkare, **sjuksköterskor**[3] och barnmorskor de få väl liksom vi andra försöka komma fram ändå utan sådana här konstifika bilar.

Herr talman, jag skall bedja att få yrka bifall till utskottets hemställan.

4. Robert Jansson (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag skall endast be att få påpeka vad som står i den kungl. propositionen och som finns refererat 1 utskottets utlåtande. Det är icke så, som man här synes vilja göra gällande, att bidrag till anskaffande och underhåll av bilar skall utgå endast till läkare. Bidrag skall utgå även till landsting, landskommun, förbund av dylika kommuner eller till sjukvårdsförening. Alla, som deltagit i det kommunala arbetet, veta. vilken fördel det innebär för en kommun att kunna skaffa sig en bil av ett eller annat slag för sjuktransport.

Herr Olsson i Kullenbergstorp framhöll olägenheterna av att bilarna voro avsedda att användas av så många olika personer: läkare, **sjuksköterskor**[3], barnmorskor etc., men, herr Olsson i Kullenbergstorp, nog blir det väl ändå så pass praktiska människor, som komma att söka anslag, så att man icke behöver ha så stora bekymmer för den saken.

Jag ber, herr talman, att få vidhålla mitt yrkande.